

Parkinson Hastalığı: Hareketin Ötesinde İlerleyici Bir Beyin Hastalığı

Parkinson hastalığı (PD), zaman içerisinde ilerleyen ve özellikle hareketleri etkileyen nörolojik bir hastalıktır. Bununla birlikte Parkinson yalnızca bir hareket bozukluğu değildir; ruh sağlığı, uyku, bilişsel işlevler, ağrı ve çeşitli diğer vücut işlevleri üzerinde de etkiler oluşturabilir. Hastalık ilerledikçe kişinin günlük yaşamını, bağımsızlığını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Dünya genelinde Parkinson hastalığına bağlı sakatlık ve ölüm oranları giderek artmaktadır. 2019 yılı tahminlerine göre dünya genelinde 8,5 milyondan fazla kişi Parkinson hastalığı ile yaşamaktadır.

Parkinson hastalığının temelinde beyindeki bazı sinir hücrelerinin hasar görmesi ve zamanla kaybedilmesi bulunur. Özellikle substantia nigra adı verilen beyin bölgesindeki dopamin üreten sinir hücreleri büyük önem taşır. Dopamin, beynin düzgün ve amaçlı hareketlerin gerçekleştirilmesini sağlayan sinyallerinde görev alan önemli bir kimyasal habercidir. Parkinson belirtileri ortaya çıktığında substantia nigra'daki dopamin üreten hücrelerin önemli bir bölümünün kaybedilmiş olduğu görülmektedir. Parkinson hastalarının çoğunda ayrıca hasar görmüş sinir hücrelerinde alfa-sinüklein adlı proteinin anormal kümeleri olan Lewy cisimcikleri bulunur. Ancak bu yapıların hastalığın oluşumundaki kesin rolü henüz tam olarak açıklanamamıştır.

Hastalığın en bilinen belirtileri hareketle ilişkilidir. Titreme, kaslarda sertlik, hareketlerde yavaşlama (bradikinezi) ve duruş ile denge bozuklukları Parkinson hastalığının temel motor belirtileri arasındadır. Titreme çoğunlukla elde başlar ve özellikle kişi dinlenirken belirginleşebilir. Kas sertliği hareketleri zorlaştırabilir ve ağrıya neden olabilir. Bradikinezi ise kişinin daha önce kolaylıkla gerçekleştirdiği yıkanma, giyinme veya yürüme gibi günlük aktiviteleri daha yavaş yapmasına yol açabilir. Hastalık ilerledikçe küçük adımlarla yürüme, öne doğru eğilme, kollarla doğal sallanmanın azalması ve hareket sırasında kısa süreli “donma” gibi yürüme sorunları da görülebilir.

Ancak Parkinson'un etkileri hareket sistemiyle sınırlı değildir. Uyku problemleri, bilişsel bozukluklar, ruh sağlığı sorunları, ağrı, yorgunluk, konuşma değişiklikleri, yutma ve çiğneme güçlüğü, idrar ve sindirim sorunları gibi motor dışı belirtiler de ortaya çıkabilir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde bazı kişilerde demans gelişebilir. Bu nedenle Parkinson, yalnızca titreme ile kendini gösteren bir hastalık olarak değerlendirilmemelidir.

Parkinson hastalığının kesin nedeni çoğu kişide bilinmemektedir. Bununla birlikte yaş önemli bir risk faktörüdür ve hastalık daha çok ileri yaşlarda görülür. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmektedir. Aile öyküsü ve bazı genetik özellikler de riski artırabilir.

Bunun yanında pestisitler, bazı endüstriyel çözücüler ve hava kirliliği gibi çevresel maruziyetlerin Parkinson hastalığı riskiyle ilişkili olabileceğine dair bulgular bulunmaktadır. Genetik yatkınlık ile çevresel faktörlerin birlikte rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Parkinson hastalığını kesin olarak ortaya koyan tek bir test bulunmamaktadır. Tanı temel olarak kişinin tıbbi öyküsü ve nörolojik muayenesi üzerinden klinik olarak değerlendirilir. Bazı laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri ise benzer belirtilere neden olabilecek diğer hastalıkların değerlendirilmesine veya tanının desteklenmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle Parkinson tanısında hastanın belirtilerinin ve nörolojik bulgularının birlikte değerlendirilmesi önemlidir.

Günümüzde Parkinson hastalığını tamamen ortadan kaldıran kesin bir tedavi bulunmamaktadır. Bununla birlikte ilaçlar, cerrahi yöntemler ve rehabilitasyon uygulamaları belirtilerin kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Levodopa/karbidopa, motor belirtilerin iyileştirilmesinde en etkili ve en yaygın kullanılan tedavilerden biridir. Bazı hastalarda derin beyin stimülasyonu gibi cerrahi yaklaşımlar da kullanılabilir. Bunun yanında fizyoterapi, yürüme ve denge eğitimi, kuvvet çalışmaları ve diğer rehabilitasyon uygulamaları

kişinin işlevselliğini ve yaşam kalitesini destekleyebilir.

Sonuç olarak Parkinson hastalığı, yalnızca ellerde ortaya çıkan bir titreme veya hareketlerin yavaşlamasından ibaret değildir. Beyindeki dopamin üreten hücrelerin kaybıyla ilişkili, ilerleyici ve hem motor hem de motor dışı birçok özelliği bulunan kapsamlı bir nörolojik hastalıktır. Hastalığın tedavisinde amaç yalnızca hareketleri düzeltmek değil, aynı zamanda kişinin günlük yaşamını, bağımsızlığını ve yaşam kalitesini mümkün olduğunca korumaktır.

Kaynaklar:

- 1) World Health Organization. (2023, August 9). Parkinson disease.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/parkinson-disease>
- 2) World Health Organization. (2022, June 14). Parkinson disease: A public health approach: Technical brief.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240050983>
- 3) National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (n.d.). Parkinson's disease. National Institutes of Health.
<https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/parkinsons-disease>

Ali Bocakkıtay/ Founder, Wionpav Labs/ Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University